

TEMA 5.11 • HEMATOLOGÍA

Alteraciones de la Hemostasia

PERFIL EUNACOM 1.07.2.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Hemostasia: Generalidades y Clasificación

Hemostasia Primaria vs. Secundaria

TABLA 5.11.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	HEMOSTASIA PRIMARIA (PLAQUETAS)	HEMOSTASIA SECUNDARIA (COAGULACIÓN)
Componente	Plaquetas	Factores de coagulación
Sangrado típico	Petequias, mucosas, epistaxis , gingivorragia	Hematomas profundos, hemartrosis
Examen alterado	Tiempo de sangría	Tiempos de coagulación (TTPK o TP/INR)

Clínica diferencial

TABLA 5.11.2: ALTERO PRIMARIA VS ALTERO SECUNDARIA	
ALTERO PRIMARIA	ALTERO SECUNDARIA
Petequias	Hematomas profundos
Equimosis superficiales	Hemartrosis
Sangrado de mucosas	
Alveolorrhagia (sangrado en extracción dental)	
Epistaxis, hipermenorrea	

Exámenes

TABLA 5.11.3: PROBLEMA VS EXAMEN ALTERADO	
PROBLEMA	EXAMEN ALTERADO
Hemostasia primaria	Tiempo de sangría ↑
He secundaria — vía intrínseca	TTPK ↑ → hemofilia , heparina
Hemostasia secundaria — vía extrínseca	TP/INR ↑ → daño hepático, cumarínicos
CID	Todo alterado (plaquetas ↓ + TTPK ↑ + TP ↑)

Clasificación de alteraciones primarias

TABLA 5.11.4: PLAQUETAS ↓ (TROMBOCITOPENIA) VS PLAQUETAS NORMALES (DISFUNCIÓN PLAQUETARIA)	
PLAQUETAS ↓ (TROMBOCITOPENIA)	PLAQUETAS NORMALES (DISFUNCIÓN PLAQUETARIA)
PTI, PTT, leucemia, aplasia medular, mielodisplasia	Von Willebrand, Glanzmann, Bernard-Soulier, AINEs

Púrpura

- **Definición clínica:** lesiones cutáneas que **no blanquean** con la compresión
- Incluye petequias y equimosis
- Primer examen → **hemograma** (¿hay trombocitopenia?)

EUNACOM CRITERIOS

Púrpura febril = urgencia → sospechar meningococemia, CID o vasculitis ANCA. Hospitalizar de inmediato.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente con petequias generalizadas, epistaxis recurrente y gingivorragia. ¿Cuál es el tipo de alteración de la hemostasia más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Alteraciones de la Hemostasia. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

- PUNTOS CLAVE DESTACADOS**
- La hemostasia primaria (plaquetas) produce petequias y sangrados de mucosas; la secundaria (coagulación) produce hematomas y hemartrosis
 - El tiempo de sangría se alarga en alteraciones de hemostasia primaria
 - Los tiempos de coagulación (TTPA, TP) se alteran en hemostasia secundaria
 - Trombocitopenia: PTI, PTT, leucemia, aplasia medular. Disfunción plaquetaria: von Willebrand, Glanzmann, Bernard-Soulier
 - TTPA alargado: hemofilia o intoxicación por heparina
 - TP alargado (INR elevado): daño hepático crónico o intoxicación por cumarínicos
 - La alveolorrhagia (sangrado post-extracción dental) es característica de alteraciones de hemostasia primaria
 - En CID se altera todo: plaquetas bajas y ambos tiempos de coagulación alargados

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ALTERACIONES DE LA HEMOSTASIA)

PREGUNTA 1

Paciente con petequias generalizadas, epistaxis recurrente y gingivorragia. ¿Cuál es el tipo de alteración de la hemostasia más probable?

- ☐ A) Alteración de hemostasia secundaria
- ☐ B) Alteración de hemostasia primaria
- ☐ C) Coagulación intravascular diseminada
- ☐ D) Deficiencia de vitamina K
- ☐ E) Hemofilia

PREGUNTA 2

Paciente con hemartrosis de rodilla y hematomas profundos en muslos. El TTPA está alargado y el TP es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) PTI
- ☐ B) Enfermedad de von Willebrand
- ☐ C) Hemofilia
- ☐ D) Daño hepático crónico
- ☐ E) Intoxicación por cumarínicos

PREGUNTA 3

¿Cuál de los siguientes hallazgos es MÁS específico de una alteración de la hemostasia primaria?

- ☐ A) Hematoma profundo
- ☐ B) Hemartrosis
- ☐ C) Equimosis
- ☐ D) Petequias
- ☐ E) TTPA alargado

RESUMEN: ALTERACIONES DE LA HEMOSTASIA

Esta clase introduce las generalidades de las alteraciones de la hemostasia, diferenciando entre hemostasia primaria (plaquetas) y hemostasia secundaria (sistema de coagulación). Ambas tienen clínica y exámenes distintos. La hemostasia primaria se manifiesta con petequias, equimosis y sangrados de mucosas (gingivorragia, epistaxis, hipermenorrea, hematuria, hemorragia digestiva, alveolorragia). Lo que se altera es el tiempo de sangría. Puede ser por trombocitopenia (PTI, PTT, leucemia, aplasia medular) o por disfunción plaquetaria con plaquetas normales (enfermedad de von Willebrand, Glanzmann, Bernard-Soulier, AINEs). La hemostasia secundaria se manifiesta con hematomas profundos y hemartrosis. Según qué tiempo de coagulación se alargue: TTPA alargado sugiere hemofilia o intoxicación por heparina; TP alargado (protrombinemia baja/INR elevado) sugiere daño hepático crónico o intoxicación por cumarínicos. En la CID se altera todo: plaquetas bajas y ambos tiempos de coagulación alargados.